

VANCOMICINA: MONITORIZAÇÃO E AJUSTE

1. Dose inicial

Calcular conforme **peso + ClCr (Cockcroft-Gault)**.

ClCr	50 a 99 kg	≥ 100 kg	Primeira vancocinemia
> 50 mL/min	1 g 12/12 h	1,5 g 12/12 h	Antes da 4ª dose
10 a 50 mL/min	1 g 24/24 h	1 g 12/12 h	Antes da 3ª dose
< 10 mL/min	1 g 24/24 h	1 g 24/24 h	24 h após a 1ª dose

O POP também define dose de ataque como **30 mg/kg/dia divididos em 12/12 h**.

Infusão

- Dose > 1 g: prolongar a infusão
 - 1,5 g: 1,5 h
 - 2 g: 2 h
 - Concentração máxima: **5 mg/mL**
-

2. Vancocinemia

Quem coleta?

Todo paciente em uso de vancomicina.

Quando?

Sempre no **VALE**, antes da próxima dose.

Em paciente sem insuficiência renal, normalmente antes da **4ª dose**.

Repetir se:

- alteração da função renal;
 - aumento da creatinina $\geq 0,5$ mg/dL;
 - melhora da insuficiência renal;
 - necessidade conforme resultado anterior.
-

3. Alvo

Situação	Vancocinemia
Mínimo aceitável	> 10 mg/L
Infecção complicada	15 a 20 mg/L
Alto risco de toxicidade	> 30 mg/L

O POP considera como infecções complicadas:

- bacteremia;
- endocardite;
- osteomielite;
- meningite;
- pneumonia hospitalar por *S. aureus*.

4. Como coletar

- Jejum: **não precisa**
- Coletar até **1 h antes da próxima dose**
- Sangue venoso, mínimo **3 mL**
- Tubo sem anticoagulante
- Enviar ao laboratório em até **2 h**
- Manter em temperatura ambiente

5. Ajuste pela vancocinemia

< 5 mg/L

Esquema atual	Novo esquema
1 g 48/48 h	1 g 24/24 h
1 g 24/24 h	1 g 12/12 h
1 g 12/12 h	1,5 g 8/8 h
1 g 8/8 h	2 g 8/8 h
1,5 g 12/12 h	2 g 8/8 h
1,5 g 8/8 h	2 g 8/8 h

Nova vancocinemia

Se veio de esquema 48/48 ou 24/24:

30 min antes da 3ª dose.

Se veio de esquema 12/12 ou 8/8:

30 min antes da 4ª dose.

Aguardar resultado antes das doses subsequentes.

6. Vancocinemia 5 a 14 mg/L

Esquema atual	Novo esquema
1 g 48/48 h	1 g 24/24 h
1 g 24/24 h	1 g 12/12 h
1 g 12/12 h	1 g 8/8 h
1 g 8/8 h	1,5 g 8/8 h
1,5 g 12/12 h	1,5 g 8/8 h
1,5 g 8/8 h	2 g 8/8 h
2 g 8/8 h	2,5 g 8/8 h

Nova vancocinemia

Se veio de 48/48 ou 24/24:

30 min antes da 3ª dose.

Se veio de 12/12 ou 8/8:

30 min antes da 4ª dose.

Aguardar resultado antes das próximas doses.

7. Vancocinemia 15 a 20 mg/L

Manter dose.

Nova vancocinemia:

30 min antes da 3ª dose após a última monitorização.

Se houver **2 vancocinemias consecutivas entre 15 e 20 mg/L**:

passar a dosar a cada 3 dias.

8. Vancocinemia 21 a 40 mg/L

Suspender a critério médico.

Repetir vancocinemia **12 h após a última mensuração.**

Reiniciar quando estiver entre **15 e 20 mg/L.**

Redução do esquema

Antes	Depois
1 g 48/48 h	1 g 72/72 h
1 g 24/24 h	1 g 48/48 h
1 g 12/12 h	1 g 24/24 h
1 g 8/8 h	1 g 12/12 h
1,5 g 12/12 h	1 g 12/12 h
1,5 g 8/8 h	1 g 8/8 h
2 g 8/8 h	1,5 g 8/8 h

Para os três primeiros esquemas, coletar nova vancocinemia **48 h após a alteração.**

Para os demais, coletar **30 min antes da 3ª dose do novo esquema.**

Aguardar resultado antes das doses subsequentes.

9. Vancocinemia > 40 mg/L

Suspender a critério médico.

Reiniciar quando a vancocinemia estiver entre:

15–20 mg/L

Nova vancocinemia **48 h após a alteração do esquema.**

Aguardar resultado antes das doses subsequentes.

10. Hemodiálise de alto fluxo

Peso	Ataque	Manutenção
< 70 kg	1 g	500 mg
70 a 100 kg	1,25 g	750 mg
> 100 kg	1,5 g	1 g

Manutenção no final da hemodiálise

- 500 mg: últimos 30 min
- 750 mg: últimos 60 min
- 1 g: últimos 90 min

Vanco	Conduta
< 5	Aumentar bastante dose/frequência conforme tabela
5 a 14	Aumentar dose/frequência conforme tabela
15 a 20	Manter
21 a 40	Suspender, repetir nível, reiniciar reduzido
> 40	Suspender, reiniciar quando 15 a 20

Vancocinemia é VALE. Coletar antes da próxima dose

Alvo do POP: 15 a 20 mg/L

Mudou função renal, repete vancocinemia